

IDENTIFICACIÓN

Apellido y Nombre:	ADER MANUEL	Número de documento:	45683086	Estado Civil:	
Tipo de documento:	D.N.I.	Edad de Atención:	22 años 2 meses	Sexo:	Masculino
Fecha de nacimiento:	26/04/2004	Dirección de domicilio:	AV. CABILDO 645 5° A	Teléfono domicilio:	1149865834
Lugar de residencia:	CABA	Parentesco:	Madre	Teléfono acompañante:	1149865834
Acompañante:	mejalelaty alejandra	Plan:	CELESTE	Numero de afiliado:	10097779003
Aseguradora:	MEDICUS	Episodio:	44861270	Clase de episodio:	Internados
Lugar de Atención:	HB Central				

Fecha Ingreso: 19/06/2026

Fecha Egreso: 29/06/2026

Epicrisis de egreso hospitalario

Condición de Egreso: Domicilio sin At. Domiciliaria

Antecedentes personales:

SMD riesgo alto q recae como LMA FLT3+ a 100 días post aloSCT haplo Luego del 1er ciclo de aza-ven-gilteritinib:

- Día +14: EMR negativa con aplasia granulocítica. Suspende VEN
- Día + 28: EMR negativa. Granulocitos 12% con stop madurativo. Suspende gilteritinib e Inicia GCSF por citopenias severas
- 8/06/2026: inicia recuperación hematológica. GB 600 con FSP con neutrófilos. PlaQ 45.000 (4 días sin transf). GR hb 9 gr/dL.
- 10/06/2026 Se solicitó WU a INCUCAI

Registro donante: IL. Compatibilidad HLA: 14/16 mm A Y DP. GRID: 498 0000 001047 03722. SEX: F. Peso: 58 kg. ABO/Rh: B+. CMV IgG:+. G:0. Transf: 0. Autorización para criopreservación del producto a la llegada a la ARG. Objetivo: iniciar el conditioning del paciente luego de la criopreservación del producto.

-18/08: confirman fecha de colecta 2/08

Motivo de internación:

Infusión 2° ciclo Quimioterapia

Resumen de Internación:

- Cursó internación para realizar 2° ciclo de Azacitidina/Venetoclax 200 mg (ajustado a isavuconazol)/Gilteritinb 120 mg/día
- 19/06: Se realiza PAMO control por persistencia de neutropenia severa a pesar de GCSF. Hb 7gr/dL, GB 800/mm3, PlaQ 3.000 con sangrado cut-mucoso. Citomorfología: MO hiper celular. Hiperplasia granulocítica y eritroide con displasia muy maracada. Blastos 18% (estimados, ya que se dificulta el conteo por el exceso de celularidad)
 - 19/06 CMF MO post C1° Azacitidina/Venetoclax 200 mg/Gilteritinb 120 mg/día: Informe verbal 22% de blastos mieloides.

* 25/06 Fue valorado por oftalmología por visión borrosa de ojo izquierdo: se observa hemorragia subacular izquierda que afecta parcialmente la macula. Conducta expectante.

Completo tratamiento antibiotico con minociclina por forunculotis.

En condiciones de egreso hospitalario en plan de continuar controles de forma ambulatoria.

Comentarios

Paciente en condiciones de egreso hospitalario. Se brindan pautas de alarma y educación acorde a diagnostico.

Responsable: STEMMELIN CAMILA

No. Matrícula MN180814

Servicio: Hematologia



HOSPITAL BRITANICO
Dra. CAMILA STEMMELIN
MIL 190.634
HEMATOLOGIA